

TEMA 4.6 • GASTROENTEROLOGÍA

Disfagia

PERFIL EUNACOM 1.06.1.013
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Disfagia

La disfagia es la **dificultad para tragar**. Su clasificación orienta inmediatamente hacia la causa y determina el estudio a solicitar.

Clasificación: Lógica vs. Ilógica

TABLA 4.6.1: CARACTERÍSTICA VS DISFAGIA LÓGICA

CARACTERÍSTICA	DISFAGIA LÓGICA	DISFAGIA ILÓGICA
Patrón	Progresiva	Fluctuante / errática
Afecta primero	Sólidos → después líquidos	Líquidos (desde el inicio)
Mecanismo	Obstrucción mecánica	Trastorno motor
Causas típicas	Cáncer de esófago	Acalasia, Esclerodermia (CREST)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de oro: disfagia que afecta líquidos desde el inicio = trastorno motor (ilógica). Si afecta sólidos primero y progresa = obstrucción (lógica).

Cáncer de Esófago

Factores de Riesgo

- **Carcinoma escamoso:** tabaquismo
- **Adenocarcinoma:** reflujo gastroesofágico crónico → **Esófago de Barrett**

Clínica

- Disfagia lógica + baja de peso (presentación clásica EUNACOM)
- El **cáncer de cardias** tiene exactamente la misma clínica y manejo

Diagnóstico

- Endoscopia digestiva alta + biopsia (confirma)
- TAC de tórax y abdomen (etapificación; en esófago el tórax es lo más importante)
- Endosonografía transesofágica (etapificación pre-quirúrgica, evalúa invasión transmural)

Tratamiento

- **Único curativo:** cirugía
- Quimioterapia + radioterapia adyuvantes (la radioterapia es especialmente relevante en esófago)

Acalasia

Clínica

- Disfagia **baja** (afecta esfínter esofágico inferior) e **ilógica**
- Carácter fluctuante
- Neumonías aspirativas a repetición
- Reflujo **no ácido** (el contenido no llegó al estómago)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El reflujo de la acalasia es NO ácido porque la comida no llega al estómago antes de devolverse.

Diagnóstico

- **Manometría esofágica** (gold standard): disminución de peristalsis + aumento del tono del EEI
- Rx de esófago con contraste (hallazgo: cuerpo esofágico dilatado + EEI contraído → imagen en "punta de lápiz")

Tratamiento

TABLA 4.6.2: OPCIÓN VS DETALLE

OPCIÓN	DETALLE
Cirugía (elección)	Esfinterotomía del EEI
Toxina botulínica	Vía endoscópica; se repite c/4-6 meses
Bloqueadores de calcio	Amlodipino; efecto modesto; producen reflujo como efecto adverso

NOTA CLÍNICA

Los bloqueadores de calcio relajan el EEI → útiles en acalasia inicial PERO como efecto adverso producen reflujo. No confundir usarlos para el reflujo (contraindicados allí).

Esclerodermia / CREST

- Disfagia **ilógica** (trastorno motor esofágico)
- Pirosis intensa (ardor retroesternal)
- Contexto: fenómeno de Raynaud, calcinosis en dedos, telangiectasias faciales
- Si la clínica de acalasia viene acompañada de signos de esclerodermia → pensar en CREST

Divertículo de Zenker

Clínica

- Disfagia **alta** (esfínter esofágico superior)
- Carácter **fluctuante** pero NO es trastorno motor
- **Halitosis** (comida se acumula y fermenta) → clave diagnóstica
- Neumonías aspirativas + regurgitación de alimentos no ácidos

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Disfagia alta + halitosis = Divertículo de Zenker. El olor diferencia este divertículo de la acalasia.

Diagnóstico

- **Rx de esófago con bario** (no endoscopia, no manometría)
- Muestra el divertículo directamente

Tratamiento

- Quirúrgico: diverticulectomía + esfinterotomía del EEI superior

Comparación Rápida: Diagnóstico por Imagen según Causa

TABLA 4.6.3: CAUSA VS EXAMEN DE ELECCIÓN

CAUSA	EXAMEN DE ELECCIÓN
Cáncer de esófago	Endoscopia + biopsia
Acalasia	Manometría esofágica
Divertículo de Zenker	Rx de esófago con bario
Divertículo del cuerpo esofágico	Asintomático → observar (descartar causa subyacente)
Divertículo del EEI	Rx con bario + cirugía (igual que Zenker)

Resumen de Disfagia Alta vs. Baja

- **Alta:** sensación de que la comida queda atrapada arriba, no puede tragarse
- **Baja:** la comida llega al tórax/estómago pero el paciente siente que "no pasa"

- Esto determina qué esfínter está comprometido:
- Alta → EES (Zenker)
- Baja → EEI (acalasia, divertículo del EEI)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 45 años con disfagia fluctuante que afecta predominantemente a líquidos, asociada a neumonías aspirativas recurrentes. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Disfagia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Disfagia lógica (progresiva, sólidos→líquidos) = obstrucción = cáncer; ilógica (fluctuante, líquidos) = motor = acalasia/esclerodermia
- Cáncer de esófago: endoscopia + biopsia; etapificación con TAC; tratamiento quirúrgico
- Acalasia: manometría (↓peristalsis + ↑tono EEI); tratamiento de elección = esfinterotomía; toxina botulínica en etapas iniciales
- Disfagia alta + halitosis = divertículo de Zenker; diagnóstico con radiografía con bario
- Divertículos: Zenker (EES) y del EEI = cirugía; del cuerpo = observar
- Bloqueadores del calcio relajan EEI: sirven en acalasia pero producen reflujo
- Esclerodermia: disfagia ilógica + pirosis + clínica de CREST

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DISFAGIA)

PREGUNTA 1

Paciente de 45 años con disfagia fluctuante que afecta predominantemente a líquidos, asociada a neumonías aspirativas recurrentes. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección?

- A)** Endoscopia digestiva alta
- B)** Radiografía con bario
- C)** Manometría esofágica
- D)** TAC de tórax
- E)** pH-metría de 24 horas

PREGUNTA 2

Paciente de 70 años con disfagia alta fluctuante y halitosis marcada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Cáncer de esófago
- B)** Acalasia
- C)** Divertículo de Zenker
- D)** Esclerodermia esofágica
- E)** Estenosis esofágica por reflujo

PREGUNTA 3

Paciente de 60 años fumador con disfagia progresiva de 3 meses que inició con sólidos y ahora afecta también líquidos, con baja de peso de 8 kg. ¿Cuál es la conducta inicial?

- A)** Manometría esofágica
- B)** Radiografía con bario
- C)** Endoscopia digestiva alta con biopsia
- D)** TAC de tórax
- E)** pH-metría de 24 horas

RESUMEN: DISFAGIA

Clase sobre disfagia (dificultad para tragar), diferenciando la disfagia lógica (progresiva, primero sólidos luego líquidos, obstrucción, típica del cáncer de esófago) de la ilógica (fluctuante, afecta líquidos desde el inicio, trastorno motor, típica de acalasia y esclerodermia). El cáncer de esófago se diagnostica con endoscopia y biopsia, etapifica con TAC, y se trata con cirugía. La acalasia se diagnostica con manometría esofágica (disminución de peristalsis + aumento del tono del EEI), se trata con esfinterotomía o toxina botulínica. Se revisan también los divertículos esofágicos: Zenker (disfagia alta con halitosis, diagnóstico con radiografía con bario, cirugía), del cuerpo (asintomático, observar) y del EEI (igual manejo que Zenker pero disfagia baja).